

张建来 mPDAC MDT 病史汇报 2026-07-16

张建来 晚期胰腺导管腺癌 MDT 病史汇报

汇报日期：2026-07-16 汇报目的：提交多学科会诊（MDT）

一、患者基本信息

项目	内容
姓名	张建来
性别	男
出生日期	1958-05-04（68 岁）
身份证号	340504195805040039
民族	汉族
籍贯	安徽省（久居北京）
职业	退休（原北京瑞尔非金属材料有限公司）
永久地址	北京市海淀区小营西路橡树湾五期万象府 8 号楼 2 单元 401
紧急联系人	张成毅（子），18600058581
当前住院	北京中关村医院 肿瘤病区（2026-06-23 起）

二、主诊断与分期

主诊断：胰腺中低分化导管腺癌（PDAC），胰头钩突占位，IV 期（cT3N1M1，肝多发转移）

病理确诊：2026-04-07 EUS-FNA 穿刺活检（北医三院） **首发症状时间：**2026 年 3 月中下旬皮肤巩膜黄染

分期依据：2026-06-14 中国医学科学院肿瘤医院上腹 MR 动态增强+DWI 明确肝多发转移瘤 **可切除性：**不可手术（SMV 受压+可疑 SMA 侵犯+肝多发转移）

三、既往史与合并症

3.1 既往合并症（2026-04-03 北医三院入院志记载）

慢病	病史	长期用药
高血压病 3 级	20 余年（最高 180 mmHg）	缬沙坦 80 mg QD + 氨氯地平 5 mg QD
高血压性脑出血	8 年（2018 年），保守治疗后好转	—
陈旧性脑梗死	3 年（2023 年），遗留双下肢无力	—
帕金森综合征	数年	雷沙吉兰 1 mg QD + 金刚烷胺 0.1 g BID + 甲钴胺 0.5 mg QD + 多巴丝肼 0.125 g-0.5 g-0.5 g TID
高脂血症	数年	阿托伐他汀 20 mg QN
脑卒中二级预防	—	西洛他唑 50 mg BID（抗血小板）

3.2 既往手术史

- **本次胰腺癌之前无任何大手术史**（2026-06-28 家属复核）
- 本次相关手术：
 - 2026-04-07 EUS-FNA 胰腺穿刺活检（北医三院）
 - 2026-04-10 ERCP + DSA 胆道**塑料**支架置入术（北医三院，张铃福医生）
 - 2026-06-22 内镜下经鼻三腔营养管置入术（北医三院普外急诊，姚炜/张耀朋，因胃潴留+十二指肠恶性狭窄）
 - **2026-07-02 十二指肠 SEMS 金属自膨胀支架置入术**（北医三院，姚炜团队；同期撤除三腔营养管，恢复口服）

3.3 过敏史

无药物、食物、造影剂过敏史（2026-06-28 家属复核）

3.4 个人史

- 生于安徽，久居北京
- **不吸烟、不饮酒**（入院志与家属双重确认）
- 无疫区/疫水、无化学放射性接触史、无吸毒史

3.5 家族史

否认家族性遗传病史与肿瘤家族史。综合”不吸烟+不饮酒+无家族肿瘤史”及基因检测（KRAS G12D + CDKN2A + Smad4 缺失）→ 提示**散发性体细胞驱动突变型 PDAC**，非遗传性。

四、诊疗时间线（关键节点）

日期	医院	关键事件
2026-02 末 / 03 初	—	出现皮肤巩膜黄染（首发症状）
2026-03-30	北京协和急诊	基线全套：CA19-9 2203 、TBIL 162.3、ALT 214、CRP 23.76、AMY 184；胸部 CT 示胆总管下段团块
2026-04-01	北京协和（国际医疗肝胆外科）	首诊：胰腺恶性肿瘤 + 梗阻性黄疸
2026-04-02	北京协和（特需基本外科）	制定”新辅助化疗 + 胆道引流”方案
2026-04-03	北医三院普外二病房（住院号 5047176）	入院；MRCP：胰头肿块 45 mm，双管征
2026-04-04	北医三院	腹盆腔 CT 增强：胰头 45 mm，与门静脉关系密切；消化系统彩超：胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm 、SMV 受压、CBD 2.3 cm 极度扩张、肝囊肿 1.5 cm、胆囊息肉 0.3 cm、 肝脏未见转移瘤 ；双下肢静脉： 无血栓（VTE 基线） ；颈动脉：双侧粥样斑块（0-49% 轻度狭窄）
2026-04-07	北医三院	EUS-FNA 穿刺活检 → 病理： 胰腺中低分化腺癌 ；超声造影示典型 PDAC 乏血供表现
2026-04-10	北医三院	ERCP + DSA 胆道塑料支架置入术 （张铃福医生）
2026-04-14	北医三院	出院；出院带药：耐信 20 mg BID + 易善复 456 mg TID + 天晴甘平 150 mg TID + 迪先 10 ml BID
2026-04-16 / 04-22	北医三院	病理免疫组化补充：MMR pMMR、HER2 1+、PD-L1 CPS<1、Smad4 缺失
2026-04-27	北医三院	NGS 报告： KRAS G12D、TP53 V274D、CDKN2A 缺失、ARID1A、MTAP 缺失、Claudin18.2 3+ 60%
2026-05-09	中国医学科学院肿瘤医院	化疗前真正基线 CT 增强（胸+全腹+盆腔+薄层） ：胰头 4.2×3.8 cm，侵犯十二指肠降+水平段、SMV、可疑 SMA； 肝多发转移瘤可能（最大 1.2×1.1 cm） ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔少量积液+腹膜稍厚；双肺结节 0.8×0.5 cm；双肾囊肿 → 实际确诊即 IV 期 mPDAC （05-12 出院时报告为 T3N0M0 II 期系初步低估）
2026-05-11	肿瘤医院	C1D1 AG 化疗 ：白蛋白紫杉醇 190 mg + 吉西他滨 1.6 g
2026-05-13	清华长庚	苏日嘎教授（肝胆肿瘤科）咨询意见
2026-05-25	肿瘤医院	C2D1（方案改为 14 天周期）

日期	医院	关键事件
2026-06-08	肿瘤医院	C3D1
2026-06-13	肿瘤医院	CT 增强疗效评估：胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm → AG 有效
2026-06-14	肿瘤医院	上腹 MR 动态增强+DWI：明确肝多发转移瘤（1.2×1.0 cm）→ 分期 II 上调 IV（mPDAC）
2026-06-18	肿瘤医院 C3D10	☑ 化验补录发现”胆管炎 3 天前驱期”完整证据链： 血常规 24 项（ MONO% 11.2 ↑ 唯一非贫血异常，EO# 0.05 临界低 ）+ 生化 19 项（ ALP 140.9 ↑ 1.13×、DBIL 4.9 ↑ 1.23× 双升胆道支架亚临床炎症；ALT 33.8 ☑、AST 26.7 ☑、TBIL 14.5 ☑ 全正常）+ 肿瘤标志物 5 项（ CA19-9 402 / CA242 77.6 ，均较 5/9 上升，含胆道支架炎症干扰）+ 凝血 10 项（ D-Dimer 1.27 ↑ 首次高凝证据 ，FDP 3.54 ☑ AT-III 94.1 ☑）
2026-06-21	急诊	☑ 反酸呕吐 24 h + 发热 39.2 °C + WBC 13.15/NEUT% 91.1%/CRP 69 + ALT 632/AST 520/ALP 540/GGT 608/TBIL 39.7 → 急性胆管炎 Grade II（胆道塑料支架相关）+ 恶性十二指肠梗阻
2026-06-22	北医三院	美罗培南 15 h 有效（PCT 2.91→1.88，AST 520→238）； 内镜下经鼻三腔营养管置入 （诊断：十二指肠降部恶性狭窄，建议必要时行 SEMS 或 EUS-GE）
2026-06-23	中关村医院肿瘤病区	转入住院（住院号 106034）； 启动双轨营养 TPF 60 ml/h 鼻饲 + PN 约 650 kcal/d；抗生素降阶梯为头孢他啶+美洛西林+左奥硝唑三联；保肝（谷胱甘肽+硫普罗宁）； 肿瘤标志物复查：CA19-9 362、CA242 37.2 （-52% vs 6/18，☑CA19-9/CA242 解偶联）； 中关村凝血 10 项： D-Dimer 1.091 ↑、FDP 8.11 ↑、FIB 425 ↑、AT:A 80 ↓ → 完整高凝四联登场 （vs 6/18 仅单项高凝）
2026-06-25	中关村	甲状腺自身抗体：TGA b 312 ↑ + TPOAb 72.2 ↑ → 桥本氏甲状腺炎 （新发现）；PCT 0.767；IL-6 23；呼吸道病原体 5 项 IgM 全阴
2026-07-01	北医三院	姚炜主任门诊 → 决定 十二指肠 SEMS 置入术 （未选 EUS-GE）
2026-07-02	北医三院胃镜室	十二指肠 SEMS 置入术 （BOSTON 6502 WallFlex 27/22×9 + Jagwire 导丝，医保 23,199 元）；同日上午北大肿瘤医院周军主任二线咨询门诊； 当天中关村凝血 10 项： D-Dimer

日期	医院	关键事件
		0.468 (-57% vs 6/23)、FDP 3.64 (-55%)、FIB 357 ☒ → 高凝四联 3/4 项 9 天内回落，仅 AT:A 76 继续降 → 感染源控制 = 最有效抗凝措施
2026-07-03	中关村	血液学全面恢复：WBC 5.42/NEUT 3.79/PLT 272/HGB 90 ↑；PCT 0.135 ☒ 感染最低点；IL-6 11.63；肝功能爆炸性恢复：ALT 25.5 (-96%)、AST 23.4 (-96%)、TBIL 7.8 (-80%) 全正常；仅 GGT 227.7 ↑
2026-07-12	中关村	☒ 全套化验三系反弹（详见”当前问题”），血常规 24 项 + 生化 19 项 + 免疫 2 项完整补录

五、当前主要问题（2026-07-16，MDT 讨论核心）

☒ 5.0 【新发现】胆管炎”隐藏 3 天前驱期” —— 4 项独立哨兵信号

☒ 本轮化验补录最震撼的临床发现（2026-07-16 补录 6/18 化验后揭示）：

6/18 C3D10（胆管炎爆发前 3 天）已经有 4 个独立指标同向异常，指向”胆道亚临床感染激活”：

系统	6/18 指标	值	参考	意义
免疫哨兵	MONO% 单核细胞	11.2 ↑	3.0-10.0	单核细胞是组织炎症的早期哨兵，胆道亚临床菌血症已激活单核系统
免疫哨兵	EO# 嗜酸粒	0.05 临界低	0.02-0.52	急性炎症应激的典型 pattern（应激皮质醇释放）
胆道生化	ALP 碱性磷酸酶	140.9 ↑	45-125	☒ 胆道支架相关早期胆汁淤积（1.13×）
胆道生化	DBIL 直接胆红素	4.9 ↑	0-4	☒ 与 ALP 同向，胆道亚临床炎症（1.23×）

同期 ALT/AST/TBIL 全部完全正常（33.8 / 26.7 / 14.5）—— 说明 6/18 时胆道感染尚在”哨兵激活但未突破肝细胞”的极早期阶段。

6/18 → 6/21 三天演变（19× 飙升）：

指标	6/18	6/21 爆发	涨幅
ALT	33.8 ☒	632 ☒☒	18.7×
AST	26.7 ☒	520 ☒☒	19.5×
ALP	140.9 ↑	540 ☒	3.8×
TBIL	14.5 ☒	39.7 ☒	2.7×
WBC	3.96 ☒	13.15 ☒	3.3×
PCT	—	2.91 ☒☒☒	63×

核心洞察三项（MDT 关注）：

- ☒ **化疗肝毒性 = 无累积** — AG 3 周期后 ALT/AST 完全正常，非累积性肝毒性
- ☒ **胆道支架亚急性炎症 = 6/18 已存在** — 塑料支架 2 个月余（4/10 置入）已进入”通畅期末期”，4 项前驱异常吻合支架细菌定植的教科书模式
- ☒ **胆管炎急性肝损伤 = 感染驱动，非慢性积累** — 3 天 19× 飙升清晰指向”感染休克式急性事件”

⚠ **家人临床直觉：**“塑料胆道支架早该换” —— 3 条独立证据链印证（4/10 塑料支架至今 3 个月+；6/18 前驱期 4 项异常；7/12 二次反弹 5 项异常）。

MDT 讨论关键推论： - 换金属胆道支架的最优时机 = 现在（TBIL 仍正常，在完全堵塞→黄疸复发→急性胆管炎爆发前主动干预） - 今后监测新指南：血常规重点看 **MONO% + EO#**（比 WBC/NEUT 敏感 ≥3 天）；生化重点看 **ALP + DBIL**（比 ALT/AST/TBIL 敏感 3 天）

☒ 5.1 亚急性胆管炎再激活 / 胆汁淤积型肝损伤反弹（7/12）

7/12 化验（中关村，采样 09:30，7/13 报告）三系同步反弹：

① 感染指标反弹

指标	6/21 峰值	7/3 最低	7/12	参考	判断
PCT	2.91	0.135	0.522 ↑	<0.046	+286%（4 倍）
IL-6	—	11.63	16.97 ↑	<7	+46%

② 肝功能（胆汁淤积型模式）

指标	7/3	7/12	参考	变化
ALT	25.5 ☒	74.4 ↑	0-40	+192% (1.86×)
AST	23.4 ☒	30.2 ☒	0-40	正常
GGT	227.7 ↑	262.1 ↑	0-50	5.24×
ALP	—	—	—	待查
TBIL	7.8 ☒	7.3 ☒	0-20	仍正常 (关键! 支架未完全堵塞)
DBIL	—	4.5 ☒	0-7	正常

③ 血液学 (感染消耗性三系反弹)

指标	7/3	7/12	参考	判断
WBC	5.42	5.53 ☒	3.50-9.50	☒ 完全正常
NEUT#	3.79	4.06 ☒	1.80-6.30	☒ 完全正常
PLT	272	111 ↓ ↓	125-350	-59% 消耗性血小板减少
LYM#	1.06 ↓	0.84 ↓	1.10-3.20	-21% 感染+化疗后叠加
LYM%	19.6 ↓	15.1 ↓	20.0-50.0	淋巴消耗持续
HGB	90	87 ↓	130-175	-3% 慢病性贫血持续
MPV	—	11.4 ↑	8.0-12.0	骨髓积极释放新血小板
P-LCR	—	37.1	13-43	年轻大血小板占比高

☒ 独特”亚急性胆道支架炎”指纹: - WBC/NEUT 完全正常 + PCT/IL-6 反弹 + ALT/GGT 升高 + LYM 消耗 + PLT 消耗 - → 既非化脓性胆管炎 (否则 WBC 应大幅升高, 如 6/21 WBC 13.15) - → 也非稳定期 (PCT/IL-6/ALT/GGT 明确反弹) - → 塑料胆道支架 3 个月堵塞导致的生物膜/低度菌血症 (慢性缓慢累积) - PLT 下降是消耗型而非骨髓抑制型 (MPV/P-LCR 高证明骨髓仍在积极生成新鲜血小板)

④ 代谢/营养 (恶病质加速——6/18 → 7/12 三周对比)

指标	6/18 基线	7/12	参考	变化	判断
ALB	34.5 ↓	32.8 ↓	35-55	-5%	低白蛋白继续加深
TP	64.4 ↓	60.0 ↓	60-85	-7%	总蛋白临界
CRE / Cr	58.5 ☒	46 ↓	59-104	-21% ☒	cachexia 明显加重（肌肉量减少，非肾问题）
Na	139.5 ☒	133.6 ↓	135-145	-4% ☒	轻度低钠新出现（高氯低钠型：PN 配比/胆道液体丢失/摄入减少）
K	4.16 ☒	3.66	3.5-5.3	-12%	临界
AMY	184 ↑ (3/30)	21.7 ☒	15-115	完全正常	☒ 排除 SEMS 术后急性胰腺炎/胰腺刺激

核心恶液质证据：Cr 58.5 → 46（3 周内 -21%）= 肌肉量明显减少的硬证据；与 MPV 上升的”骨髓消耗-代偿”现象共同表明系统性消耗加速。

临床判断（证据链完整）： - 无发热、无腹痛、TBIL 正常 → 未达急性化脓性胆管炎，处于亚急性感染激活期 - ALT/GGT/PCT/IL-6 同步反弹 → 病因同源 - **鉴别诊断三选一：** 1. 胆道塑料支架 3 个月堵塞 / 生物膜（40%）——4/10 置入至今 3 个月余，已入通畅期末期 2. 舒普深 + PN 药物性胆汁淤积 20 天暴露（30%） 3. 两者叠加（20%）

△ 家属临床直觉： 7/12 早间家人即提出”应早换金属胆道支架，为何 SEMS 手术未同期置换？”—— 化验后 3 条独立证据链印证此判断。

5.2 十二指肠 SEMS 术后（2026-07-02，D13）

- **恢复良好：** 已停鼻饲/PN，营养全改口服；无腹痛、无出血、无支架移位
- **AMY 21.7 正常** → 排除胰腺刺激
- 需影像复查（腹部 CT 或超声）确认支架位置和胆道情况

5.3 化疗方案与耐药风险

- **AG 方案 C3 完成，一线响应良好**（6/13 CT：肝结节缩小、淋巴结 0.9→0.7 cm）
- 因 6/21 胆管炎急诊后中断化疗至今（3 周多），需评估是否继续 C4 及节奏调整
- **AG 中位 PFS 5.5-6 个月**（MPACT 研究），爸爸 5/11 起，7/15 已 2 个月余，需警惕耐药窗口

5.4 桥本氏甲状腺炎（新发现，2026-06-25）

- TGAb 312 ↑ (2.7×) + TPOAb 72.2 ↑ (2.1×); TRAb 正常
- 甲功五项待查
- 若拟入组免疫治疗试验（如恒瑞 HRS-4642 + Adebrelimab PD-L1），需先评估甲功基线

5.5 高凝状态与抗血小板/抗凝策略

- 6/24 D-Dimer 1.091 ↑ ↑; 7/3 已回落至 0.468 (-57%), 无新发 DVT
- 4/4 双下肢基线无血栓
- 当前抗血小板: **西洛他唑 50 mg BID** (脑卒中二级预防继续)
- ⚠ 7/12 PLT 111 (消耗性减少) + 西洛他唑 → **出血风险 vs 血栓预防**需 MDT 判断是否暂停或减量

六、关键影像学总结

检查	日期	医院	关键发现
胸部 CT 平扫	2026-03-30	协和急诊	胆总管下段团块，双肺微小结节
MRCP	2026-04-03	北医三院	胰头肿块 45 mm，双管征
腹盆腔 CT 增强	2026-04-04	北医三院	胰头 45 mm，与门静脉关系密切
消化系统彩超	2026-04-04	北医三院	胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm + SMV 受压 + CBD 2.3 cm 扩张 + 肝脏未见转移
超声造影（穿刺同期）	2026-04-07	北医三院	典型 PDAC 乏血供廓清早于胰腺组织
化疗前基线 CT 增强 +薄层	2026-05-09	肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm；侵犯十二指肠降 +水平段 + SMV + 可疑 SMA； 肝多发转移瘤可能 (1.2×1.1 cm) ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔积液；双肺结节；双肾囊肿
AG 疗效评估 CT 增强	2026-06-13	肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm； AG 有效
上腹 MR 动态增强 +DWI	2026-06-14	肿瘤医院	胰头 4.9×3.8 cm；肝多发 DWI 高信号结节 1.2×1.0 cm → 明确诊断”肝多发转移瘤”（分期升至 IV）

七、分子病理与基因检测（NGS 2026-04-27）

检测	结果	临床意义
KRAS	G12D (c.35G>A, VAF 26.94%)	驱动突变；G12D 特异性抑制剂在研（HRS-4642 / Zoldonrasib / GFH375 / INCB161734）
TP53	V274D (c.821T>A, 37.12%)	抑癌基因失活；WEE1 抑制剂潜在靶点
CDKN2A	拷贝数缺失（CN=1.16）	细胞周期失调
ARID1A	D2178Gfs*47 (24.19%)	功能丧失
MTAP	杂合缺失（9p21.3）	MAT2A 抑制剂靶点（在研）
RNF43	A46S	Wnt 通路，意义不明
BIRC3	BIRC3-METTL25B 融合（15.43%）	意义不明
MSI	MSS	免疫单药无效
TMB	4.1 突变/Mb（低）	免疫单药无效
PD-L1	阴性（CPS<1, SP263）	免疫单药无效
Smad4/DPC4	表达缺失	预后不良，倾向远处转移；提示吉西他滨方案更适合
HER2	1+（低表达）	传统 HER2 靶向药不适；T-DXd 潜在二线备选
MMR	pMMR（四项正常）	与 MSS 一致
Claudin 18.2	阳性（60%，3+）	符合 CLDN18.2 靶向治疗标准（Zolbetuximab、CLDN18.2 ADC、CT041 CAR-T）
BRCA1/2	无突变	PARP 抑制剂不适

核心可干预靶点：
KRAS G12D（一级）+ Claudin 18.2 3+ 60%（一级）+ TP53/CDKN2A/MTAP（研究级）

八、当前用药清单

8.1 慢病长期用药（需 MDT 核对本次住院期间是否维持）

药物	剂量	频次	用途
缬沙坦（代文）	80 mg	QD	高血压
氨氯地平（络活喜）	5 mg	QD	高血压
雷沙吉兰	1 mg	QD	帕金森综合征
金刚烷胺	0.1 g	BID	帕金森综合征
甲钴胺	0.5 mg	QD	帕金森综合征
多巴丝肼（美多巴）	0.125-0.5-0.5 g	TID	帕金森综合征
阿托伐他汀	20 mg	QN	调脂
西洛他唑	50 mg	BID	脑卒中二级预防（抗血小板）— △ 7/12 PLT 111, 需评估

8.2 出院/化疗相关用药

药物	剂量	频次	用途
艾司奥美拉唑镁（耐信）	20 mg	BID	PPI 抑酸
多烯磷脂酰胆碱（易善复）	456 mg	TID	保肝
甘草酸二铵（天晴甘平）	150 mg	TID	保肝抗炎
硫糖铝（迪先）	10 ml	BID	黏膜保护
白蛋白结合型紫杉醇	190 mg	ivgtt d1 q14d	AG 化疗（末次 6/8）
吉西他滨	1.6 g	ivgtt d1 q14d	AG 化疗（末次 6/8）
昂丹司琼	8 mg	按需 q8-12h	化疗止呕

8.3 本次住院期间（中关村，2026-06-23 起）

药物	用途	备注
头孢他啶 + 美洛西林 + 左奥硝唑	抗感染三联（美罗培南降阶梯）	已用约 3 周
舒普深	抗感染	累计约 20 天
谷胱甘肽 1.2 g + 硫普罗宁 0.1 g	保肝	—
脂肪乳 + 氨基酸 + 葡萄糖 + 电解质	PN 全静脉营养（约 650 kcal/d）	7/2 SEMS 后已停
TPF 肠内营养 60 ml/h 鼻饲	肠内营养	7/2 SEMS 后已停，改口服

九、关键指标趋势

9.1 CA19-9 与 CA242（肿瘤标志物解偶联 ☒）

日期	CA19-9	CA242	说明
2026-03-30	2203 ☒	125.8 ☒	基线（重度黄疸）
2026-05-09	255	52.9	↓ 88% / ↓ 58%（主因 ERCP 引流）
2026-06-18	402 ↑	77.6 ↑	C3D10: CA19-9 +58% / CA242 +47%（含胆道支架亚临床炎症干扰）
2026-06-23	362 ↑	37.2 ☒	胆管炎爆发 D2; ☒ CA242 从 6/18 骤降 52%，vs 5/9 净降 30% ☒
2026-06-24	362	37.2	同批次报告

☒☒☒ 核心洞察：CA19-9 与 CA242 解偶联 - CA19-9 5/9 → 6/23: ↑ 42%（受胆道支架炎症干扰） - CA242 5/9 → 6/23: ↓ 30%（真实肿瘤生化应答） - → AG 方案可能仍有生化效果，之前”生化 PD”判断需修正为”混合应答（审慎乐观）” - MDT 建议：炎症完全消退（PCT 正常 ≥ 2 周）后复查 CA19-9+CA242，判定真实肿瘤应答

9.2 TBIL（总胆红素）

2026-03-30: 162.3 → 05-09: 53.8 (-67%) → 05-19: 29.9 (-82%) → 07-03: 7.8 ☒ → 07-12: 7.3 ☒（仍正常）

关键：7/12 ALT/GGT 反弹但 TBIL 未升 → 胆道支架未完全堵塞，处于早期干预窗

9.3 化疗骨髓抑制轨迹

时点	WBC	NEUT	HGB	PLT	备注
5/9 化疗前	5.06	—	100	215	基线
5/16 C1D5	3.42 ↓	2.01	96	216	
5/28 C1D17	3.54	2.21	82 ↓ ↓	333	
5/31 C2D6	2.63 ↓ ↓	1.18 ↓ ↓	85	321	II 度粒减 + WBC 减
6/3 C2D9	3.68	1.82	81	225	
6/18 C3D10	3.96 ☒	2.12 ☒	97 ↑	220 ☒	☒ 胆管炎前基线： 骨髓已充分恢复 (HGB 回升 20%)
7/3 C3D25 (SEMS 后 D1)	5.42 ☒	3.79 ☒	90	272	全面恢复
7/12 C3D34	5.53 ☒	4.06 ☒	87 ↓	111 ↓ ↓	☒ PLT 大幅下降 (消耗型，非骨髓抑制型)

9.4 感染监测轨迹（PCT / IL-6）

日期	PCT	IL-6	事件
6/21	2.91 ☒☒☒	—	☒ 急性胆管炎爆发
6/22	1.88	—	美罗培南 15 h -35%
6/25 (=6/24 采样)	0.767	23	抗生素降阶梯
7/3	0.135 ☒	11.63	最低点
7/9	0.396 ↑	23.64 ↑	SEMS 术后 D7 早期反弹
7/12	0.522 ↑ ↑	16.97 ↑	△ 反弹 4 倍，胆道感染再激活

9.5 【新增】高凝状态三阶段演变（凝血四联）

时点	D-Dimer	FDP	FIB	AT:A	阶段	备注
4/4 基线	—	—	—	—	干净	双下肢静脉超声无血栓
6/18 (C3D10)	1.27 ↑	3.54 ☒	369	94.1 ☒	Phase 1: 慢性高凝	☒ 仅 D-Dimer 孤立升高 (CAT 模式: 肿瘤+化疗+卧床+多导管), 无炎症干扰
6/23 (胆管炎 D2)	1.091 ↑	8.11 ↑	425 ↑	80 ↓	Phase 2: 完整高凝四联	☒ FDP +129% 爆发 + AT:A 消耗启动; PT/APTT 仍正常 (未 DIC)
7/2 (SEMS 术后)	0.468 ↑	3.64 ☒	357 ☒	76 ↓	Phase 3: 消退期	☒ FDP -55%、FIB -16%、D-Dimer -57% 三项回落; 唯 AT:A 继续降 (抗凝储备恢复滞后)
7/3	0.468	—	—	—	稳定	无新发 DVT/PE

☒ **核心洞察**：SEMS 术后 D-Dimer 5 天内从 1.091 → 0.468 (-57%)，说明 “**感染源控制 = 最有效的抗凝措施**”，非药物性抗凝。

9.6 【新增】三大医学判断硬确定（基于 6/18 前驱期数据）

- 1. ☒ **化疗肝毒性 = 无累积**（AG 3 周期后 ALT 33.8 / AST 26.7 完全正常）
- 2. ☒ **胆道支架亚急性炎症 = 6/18 已存在**（4 项前驱异常：MONO% / EO / ALP / DBIL）
- 3. ☒ **胆管炎急性肝损伤 = 感染驱动，非慢性积累**（3 天 19× 飙升的教科书级”感染休克式”急性事件）

十、MDT 讨论要点

☒ **讨论问题 1（最紧迫）：胆道塑料支架处置**

背景（证据链已扩展至 5 条）：4/10 置入胆道塑料支架已 3 个月零 6 天。

5 条独立证据链印证” 塑料支架相关胆道感染再激活”： 1. **6/18 前驱期（新发现）：**4 项独立哨兵异常（MONO% ↑ + EO# ↓ + ALP ↑ + DBIL ↑） 2. **6/21 急性爆发：**ALT/AST 3 天 19× 飙升 + PCT 63× + 发热 39.2 °C 3. **6/23 高凝四联登场：**D-Dimer/FDP/FIB/AT:A 四联异常 4. **7/2 SEMS 术后回落：**D-Dimer -57%、FDP -55%，证明感染源控制起效 5. **7/12 二次反弹：**PCT +286%、ALT +192%、GGT 5.24×、PLT 消耗 -59%，TBIL 仍正常表明处于**早期干预窗**

MDT 请讨论： 1. 是否择期（1-2 周内）行 ERCP 更换为**金属自膨胀胆道支架（SEMS）**？（家属临床直觉一贯支持） 2. 还是先行影像（腹部超声 / MRCP）确认支架状态后再决策？ 3. 若更换支架，抗生素是否需先升级或行血培养 + 胆汁培养定向？ 4. 换支架窗口与化疗恢复的时序如何安排？

☒ 讨论问题 2：化疗恢复与调整

背景： AG 一线 C3 完成，6/13 CT 显示有效；因 6/21 胆管炎中断至今 3 周多。

MDT 请讨论： 1. C4 何时启动？（等胆道处理后 vs 处理同期启动） 2. 是否需减量（5/31 曾出现 II 度粒减）？ 3. 是否维持 14 天周期不变？

☒ 讨论问题 3：临床试验入组方向

匹配靶点： KRAS G12D + Claudin 18.2 3+ 60%

候选试验（招募中）： 1. **NCT07296341：**HRS-4642（恒瑞 KRAS G12D 抑制剂）+ Adebrelimab + AG，II 期一线 mPDAC（协和已列，307 待查） 2. **NCT07621718：**Zoldonrasib（RMC-9805）+ 化疗 vs 安慰剂 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D（中国分中心待查） 3. **NCT07522073：**INCB161734 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D 4. **NCT07255404：**BNT327（PD-L1/VEGF-A 双抗）+ AG/mFOLFIRINOX，II 期一线（清华长庚为中国中心） 5. **NCT07235202：**MR001 + 二线化疗，II 期（清华长庚） 6. **CT041（科济 CLDN18.2 CAR-T）：**PDAC 队列全球 II 期 7. **HLA 分型待查——**若 HLA-C*08:02，可评估 KRAS G12D TCR-T（Anocca ANOC-003 / 国内在研团队）

MDT 请讨论： 1. 当前时机是否合适启动试验筛查？（vs 继续 AG 到耐药后再切换） 2. 优先建议哪条路径（KRAS G12D 抑制剂 vs CLDN18.2 靶向 vs TCR-T）？ 3. 是否建议先做 HLA 分型？

☒ 讨论问题 4：抗血小板策略

背景： 西洛他唑 50 mg BID（脑卒中二级预防，长期）+ 7/12 PLT 111（-59%）+ 无新发血栓但 D-Dimer 曾峰值 1.091

MDT 请讨论： 1. 西洛他唑是否需暂停或减量至 PLT 恢复？ 2. 若需 ERCP 换支架，围术期停药方案？

☒ 讨论问题 5：营养与恶病质

背景： ALB 32.8 ↓ + Cr 46 ↓（肌肉量减少）+ Na 133.6 ↓ + 体重较基线 -5 kg

MDT 请讨论： 1. 是否需恢复短期 PN 支持？ 2. 白蛋白输注指征？ 3. 神经科营养/帕金森长期用药是否影响吞咽功能与经口摄入？

十一、既往就诊/咨询医生一览

医院	科室	医生	事件
北京协和医院	国际医疗肝胆外科 / 特需基本外科	—	2026-04-01/02 首诊
北京大学第三医院	普外二病房	马新晖 / 伍佳龙	2026-04-03 入院志签字
北京大学第三医院	ERCP	张铃福	2026-04-10 胆道塑料支架置入 ☑
北京大学第三医院	普外急诊	姚炜 / 张耀朋 / 郁炜	2026-06-22 三腔营养管
北京大学第三医院	内镜中心	姚炜团队	2026-07-02 十二指肠 SEMS ☑
中国医学科学院肿瘤医院	内科 2 廊坊院区	田爱茹	AG 化疗主管 ☑
中国医学科学院肿瘤医院	胰胃外科	王敏	2026-04-07 门诊
北京朝阳医院	肝胆胰腺外科	樊华	2026-04-24 第二意见
北京清华长庚医院	肝胆肿瘤科	苏日嘎	2026-05-13 咨询
北京大学肿瘤医院	—	周军	2026-07-02 二线咨询
北京中关村医院	肿瘤病区	主管医生	2026-06-23 至今住院 ☑

十二、患者与家属诉求

1. **争取 OS 最大化**（爸爸 IV 期 mPDAC，AG 一线响应中，希望规划好二线/联合治疗与临床试验窗口）
2. **减少并发症对生活质量的破坏**（本次胆管炎+呕吐是最痛苦的一次）
3. **信息透明**——家属希望与 MDT 充分沟通治疗决策的证据与备选方案
4. **积极但不激进**——不追求任何未经验证的疗法，一切基于循证与临床试验合规路径

附录：数据版本信息

- 数据截止时间：2026-07-16
- 报告版本：**v1.1**（v1.0 基础上补入 6/18 肿瘤医院血常规 24 + 生化 19 + 肿瘤标志物 5 + 凝血 10 + 7/2 SEMS 当天中关村凝血 10 + 7/12 中关村血常规 24 + 生化 19，共 111 条新增化验记录，全部录入飞书多维表格「检查指标」tblYz1xzKOFrg6yW）
- 关键新增：§ 5.0 胆管炎“隐藏 3 天前驱期” + § 9.5 高凝三阶段演变 + § 9.6 三大医学判断硬确定 + § 9.1 CA19-9/CA242 解偶联
- 生成方式：由家属维护的健康记录系统（含飞书多维表格 + 本地 workspace + 每日临床事件日志）汇总
- 联系人：张成毅（子）18600058581 / robinzhangcy@gmail.com

⚠ 本报告为家属整理的病史汇报文档，供 MDT 讨论参考。所有诊疗决策以主管医生和 MDT 意见为准。